ALTAMEDICA
ARTEMISIA

Servizio di Genetica Medica
ARTEMISIA SPA - P. IVA 00929551000
00198 ROMA - Viale Liegi, 45
Tel 06 85 05 804-5-6 | Centralino 06 85 05 (r.a.)
www.altamedica.it - segreteria.geneticamedica@altamedica.it
Resp. Dott. Alvaro Mesoraca
Certificazione di Qualità UNI EN ISO 9001

Il tuo profilo genetico ha evidenziato

UNA PREDISPOSIZIONE GENETICA ALLA CARENZA DI FERRO

Nel tuo caso la predisposizione alla carenza di Ferro è legata ad una mutazione del *gene TMPRSS6*, che codifica per la proteina *Matriptasi-2*, il principale inibitore di *Epcidina*. L'*Epcidina* è un regolatore chiave dell'equilibrio del Ferro nel corpo. Quando i livelli di ferro nel sangue sono bassi, questa via di segnalazione riduce la produzione di Epcidina consentendo di assorbire più ferro dall'alimentazione attraverso l'intestino. Se è presente una mutazione nella codifica della proteina Matriptasi-2 allora la produzione di Epcidina è alterata e si ha un minor assorbimento di Ferro.

Il Ferro ha moltissimi ruoli fondamentali all'interno dell'organismo, in particolare è coinvolto nel trasferimento di ossigeno. È un componente essenziale dell'emoglobina, la quale trasporta ossigeno dai polmoni a tutti i tessuti e raccoglie anidride carbonica.

Una carenza di ferro può avere diverse conseguenze per l'organismo, tra cui l'*anemia sideropenica*. Si tratta di una condizione in cui nell'organismo non vi sono adeguati livelli di ferro e questo compromette il trasporto di ossigeno attraverso il sangue, provocando anche stanchezza e fiato corto.

Gli studi dimostrano che lo sviluppo cognitivo di un bambino può essere influenzato anche dalla carenza di ferro della madre durante la gravidanza, in particolare nell'ultimo trimestre.

Il fabbisogno medio giornaliero di Ferro è dai 6 mg ai 10 mg al giorno. Durante la gravidanza aumenta fino a 22 mg al giorno.

Consigli alimentari in base al tuo profilo genetico:

Sono strettamente consigliati alimenti ricchi di Ferro, come:
Manzo (massimo 1-2 volte a settimana), pollo, tacchino
Frumento, avena
Legumi, soia secca
Rucola, basilico
Pistacchi, anacardi
Pepe nero, menta, rosmarino, prezzemolo
Cacao amaro in polvere, tè in foglie, cioccolato fondente

Bibliografia

https://sinu.it/2019/07/09/minerali-fabbisogno-medio-ar/
DeLoughery TG. *Iron Deficiency Anemia*. Med Clin North Am. 2017 Mar;101(2):319-332. doi: 10.1016/j.mcna.2016.09.004. Epub 2016 Dec 8. PMID: 28189173.
Melis MA, Cau M, Congiu R, Sole G, Barella S, Cao A, Westerman M, Cazzola M, Galanello R. *A mutation in the TMPRSS6 gene, encoding a transmembrane serine protease that suppresses hepcidin production, in familial iron deficiency anemia refractory to oral iron*. Haematologica. 2008 Oct;93(10):1473-9. doi: 10.3324/haematol.13342. Epub 2008 Jul 4. PMID: 18603562.